

Tạo hình niệu đạo (Phẫu thuật sửa chữa hẹp niệu đạo)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật sửa chữa hẹp niệu đạo

Tạo hình niệu đạo là phẫu thuật sửa chữa đoạn niệu đạo bị hẹp hoặc có sẹo — ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. Chỗ hẹp (hẹp niệu đạo) làm yếu hoặc tắc dòng nước tiểu; tạo hình niệu đạo mở lại lòng ống và là phương pháp sửa chữa bền vững nhất. Tờ hướng dẫn này giải thích cách thực hiện, cách chuẩn bị và những gì cần biết sau phẫu thuật.

Về ca phẫu thuật này

Hẹp niệu đạo là đoạn niệu đạo bị sẹo, thu hẹp làm khó làm trống bàng quang. Không giống như việc chỉ nong hay rạch chỗ hẹp (thường tái phát), tạo hình niệu đạo **tái tạo** niệu đạo về kích thước bình thường — phương pháp tin cậy và lâu dài nhất, với tỷ lệ thành công khoảng **85–95%**. Cách thực hiện phụ thuộc vào vị trí và độ dài chỗ hẹp:

- Đường **rạch** có thể ở **dương vật**, vùng giữa bìu và hậu môn (**tầng sinh môn**), hoặc cả hai — tùy vị trí chỗ hẹp.
- Chỗ hẹp **ngắn** có thể **được cắt bỏ và khâu nối hai đầu lành lại**.
- Chỗ hẹp **dài hơn** được **mở rộng bằng mảnh ghép** — thường là mảnh niêm mạc từ bên trong má (có tờ hướng dẫn riêng).

Bác sĩ phẫu thuật sẽ giải thích phương pháp phù hợp với tình trạng của bạn.

Có an toàn không?

Tạo hình niệu đạo là một phẫu thuật được thực hiện rộng rãi và rất hiệu quả; hầu hết bệnh nhân có niệu đạo thông thoáng lâu dài sau đó. Như mọi phẫu thuật, có một số nguy cơ — chảy máu, nhiễm trùng, hoặc hẹp tái phát theo thời gian (thường có thể điều trị lại). Ảnh hưởng đến cương dương hoặc xuất tinh ít gặp và thường chỉ tạm thời.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể.

Hẹp niệu đạo

Đoạn niệu đạo bị sẹo, thu hẹp làm yếu hoặc tắc dòng nước tiểu.

Tạo hình niệu đạo

Phẫu thuật sửa chữa chỗ hẹp và tái tạo niệu đạo về kích thước bình thường.

Mảnh ghép

Mảnh mô của chính bạn (thường từ niêm mạc má) dùng để mở rộng niệu đạo.

Tầng sinh môn

Vùng giữa bìu và hậu môn, nơi thường có một đường rạch phẫu thuật.

Ống thông

Ống mềm đặt trong niệu đạo khoảng 1–4 tuần để vết thương lành.

Chụp X-quang niệu đạo

Hình ảnh X-quang của niệu đạo, kiểm tra vết mổ đã lành trước khi rút ống thông.

Gây mê toàn thân

Thuốc giữ bạn ngủ và không đau trong suốt phẫu thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, bạn sẽ có cảm giác đau nhức, sưng và bầm tím quanh vết rạch (dương vật và/hoặc tầng sinh môn) trong vài tuần — chườm đá, dây đỡ bìu và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Ống thông sẽ được đặt khi bạn tỉnh dậy. Thời gian phẫu thuật tùy theo loại sửa chữa, thường 2–4 giờ.

Cách chuẩn bị (Trước khi phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân thủ mọi hướng dẫn trước mổ (nhịn ăn, và các thuốc cần tạm ngừng, kể cả thuốc chống đông máu).
- Xét nghiệm nước tiểu** kiểm tra nhiễm trùng — nếu có nhiễm trùng phải điều trị trước.
- Không hút thuốc** — thuốc lá làm chậm lành thương. Nếu có thể dùng mảnh ghép niêm mạc má, hãy giữ vệ sinh răng miệng tốt; có thể được khuyến nghị lấy cao răng.
- Chuẩn bị cho việc **đặt ống thông sau mổ (khoảng 1–4 tuần)** và sắp xếp người đưa về nhà.

Báo trước cho nhóm chăm sóc nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc chống đông máu**, hoặc đang có nhiễm trùng đường tiểu hay da
- Đã từng phẫu thuật niệu đạo, xạ trị, hoặc mắc bệnh da như lichen xơ hóa

Quá trình phẫu thuật

- Bạn được gây mê hoặc gây tê từ thắt lưng xuống; thuốc kháng sinh được dùng trước mổ.
- Bác sĩ rạch da tại vị trí chỗ hẹp (dương vật, tầng sinh môn, hoặc cả hai) và mở đoạn sẹo.
- Chỗ hẹp được sửa chữa — cắt bỏ và khâu nối hai đầu lại, hoặc mở rộng bằng mảnh ghép.
- Ống thông** được đặt để dẫn nước tiểu và bảo vệ vết khâu trong khi lành; các vết rạch được đóng lại.

Sau khi phẫu thuật

- Bạn về nhà với **ống thông**, thường trong **khoảng 1–4 tuần**. Nhóm chăm sóc sẽ hướng dẫn cách chăm sóc ống thông — không kéo hay giật ống.
- Sưng, bầm tím và **nước tiểu có chút máu** quanh ống thông là bình thường trong giai đoạn đầu.
- Tránh nâng vật nặng, rặn, đạp xe và quan hệ tình dục** trong vài tuần (thường khoảng 6 tuần) để vết mổ lành.
- Trước khi rút ống thông, bạn thường được **chụp X-quang niệu đạo** để xác nhận vết mổ đã lành.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Ống thông **bị tuột ra, tắc nghẽn, hoặc ngừng chảy**
- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc vết rạch ngày càng đỏ, đau hoặc chảy dịch
- Chảy máu nhiều, hoặc **không đi tiểu được** sau khi rút ống thông

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Tạo hình niệu đạo tái tạo niệu đạo bị hẹp và là phương pháp sửa chữa bền vững nhất. Đường rạch có thể ở dương vật, tầng sinh môn hoặc cả hai, và có thể dùng mảnh ghép (thường từ niêm mạc má) — bác sĩ sẽ giải thích cụ thể.
- Để chuẩn bị: tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc, điều trị nhiễm trùng trước, không hút thuốc, và chuẩn bị cho việc đặt ống thông sau mổ (khoảng 1–4 tuần).
- Giữ ống thông cho đến khi nhóm chăm sóc rút ra (thường sau khi chụp X-quang kiểm tra), tránh nâng vật nặng, rặn và quan hệ tình dục trong vài tuần.